疫情应激性失眠管理专家指导意见

中华中医药学会心身医学分会

中图分类号：R256　　文献标识码：A　　文章编号：2095-8552（2022）10-1147-07
doi:10.3969/j.issn.2095-8552.2020.10.006

失眠是常见的睡眠问题，对人体心身健康有着明显的危害，突发事件造成的应激性失眠，约占失眠的2/3[1]。疫情作为突发的公共卫生事件，是强大的心理应激源，导致公众的紧张、恐惧、焦虑、抑郁、失眠等心理健康问题凸显[2-3]。过度应激又作为诱发因素引起应激性失眠，两者相互影响、恶性循环，疫情应激性失眠应引起社会的高度重视。为充分发挥中医健康管理的特色和优势，针对疫情后高发的应激性失眠，中华中医药学会心身医学分会组织专家拟定《疫情应激性失眠管理专家指导意见》（简称《意见》）如下。

1 概述

应激性失眠是指由于思虑过度、兴奋不安或焦虑烦恼等精神因素引起的失眠，主要由心理应激和负性生活事件诱发，二者不仅是新发失眠的危险因素，也是急性失眠得以慢性化的维持因素[4]。应激性失眠一般在应激因素去除或适应能力增强后数天至数周内可缓解；但若再遇情绪刺激等因素可复发；如应激因素持续不去，可导致病程延长；如处理不当，形成错误的认知及行为，即使病因去除后，失眠依然存在，约40%的应激性失眠可发展成为慢性失眠，是失眠慢性化的关键阶段[5-6]。失眠慢性化又是诱发焦虑症、抑郁症、强迫症等多种精神心理疾病及高血压、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑血管病、肿瘤等躯体疾病发生发展的重要诱因。同时，疫情应激性失眠也与自杀性事件发生相关[7]。另外，研究显示，疫情应激导致一线医务人员失眠的比例高达61.67%，有26.67%的人群甚至出现重度失眠[8]，且医务人员的睡眠质量与焦虑、抑郁等不良情绪显著相关[9]，对公众生命健康造成严重威胁。

参考中国睡眠研究会2017年组织编制的《中国失眠症诊断和治疗指南》对失眠症的诊断标准[10]，将失眠症分为慢性失眠症、短期失眠症及其他类型的失眠症。慢性失眠症的诊断要求：病程≥3个月及频度≥3次/周，短期失眠症的诊断标准与慢性失眠症类似，但病程少于3个月，且没有频率的要求。按严重程度可分为[11]：①轻度：偶发，对生活质量影响小。②中度：中度影响生活质量，伴随一定症状（易怒、焦虑、疲乏等）。③重度：严重影响生活质量，临床症状表现突出。

失眠属于中医“不寐”范畴，病机总属阳盛阴衰，阴阳失衡。以此为指导，在失眠治疗中可取得显著疗效[12]。中医学蕴含丰富的睡眠管理策略和心身调适技术，在中医“未病先防、既病防变、瘥后防复”的治未病思想指导下，提出“早预防、早诊断、早干预、调心身、贯全程”的应激性失眠管理策略，旨在有效降低应激性失眠的发生率，缓解失眠心身紊乱的症状，降低转为慢性失眠的比例，减少与失眠相关的心身疾病发生，提高患者生活质量。

2 评估

2.1 信息采集

2.1.1 *病史采集*　全面采集失眠病史，如失眠的临床表现，包括睡前状况、睡眠—觉醒节律、夜间症状、日间症状等；患者起病前的个性特征、个人成长经历、既往史、家族史、家庭环境、工作环境等；失眠初发时的场景、应激的来源、性质、程度及持续时间；失眠病程的演变过程等。

2.1.2 *症状体征*　搜集、整理患者的临床症状、相关体征及中医四诊信息等，进行详细的体格检查，关注特殊的就诊行为，可以起到快速诊断的目的，如自带字条，自我详细介绍病情，列出各种症状，唯恐有遗漏；出示大量的化验检查结果，虽有部分阳性结果，却不能用以解释现有的各种症状；候诊烦躁，反复出入于门诊，不停地询问担心的问题；说话唠叨，难以打断，缺乏逻辑和层次；沟通困难，固执己见，多疑善感；病史长，症状多，病情复杂，四处求医，时觉有效，时觉无效；同时挂号多个科室，却未取药等[13]。

2.1.3 *辅助检查*　完成常规的实验室检查、影像学检查和必要的功能检查等，以明确器质性病变和/或

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

功能异常。

2.2 量表评估

2.2.1 压力源评估 采用突发性公共卫生事件心理问卷[14]、生活事件量表[15]、赫尔姆斯的社会再适应量表[16]及布朗生活事件和困难量表[17]等。

2.2.2 失眠易感性评估 采用福特应激失眠反应量表（中文版）[18]等。

2.2.3 失眠情况评估 ①睡眠基本情况：Spiegel 睡眠问卷[19]、睡眠日志、Epworth 嗜睡量表[20]、清晨型—夜晚型量表[21]等。②睡眠质量：匹兹堡睡眠质量指数量表[22]、失眠严重程度指数[23]、睡眠障碍评定量表[24]等。③睡眠认知：睡眠不良信念与态度量表[25]等。④失眠客观评估：多导睡眠图和多次睡眠潜伏期试验等[26-27]；

2.2.4 精神心理评估 ①焦虑状态量表：焦虑自评量表[28]、汉密尔顿焦虑量表[29]。②抑郁状态量表：抑郁自评量表[30]、汉密尔顿抑郁量表[31]、抑郁筛查量表[32]、贝克抑郁自评量表[33]。③人格量表：明尼苏达多相人格调查表[34]、艾森克人格问卷[35]等。

2.2.5 日间症状评估 采用心身症状自评问卷[36]、躯体症状群量表[37]、疲劳自评量表[38]、中医证候要素量表等。

3 管理

针对疫情应激性失眠的治疗，可参考《失眠症中医临床实践指南》[39]《中国失眠障碍综合防治指南》[40]等。短期失眠通常与应激、冲突或引起情绪明显波动的心理和环境变化相关，常在应激反应警觉期和抵抗期出现，其基本特征为短期睡眠起始困难和维持困难，并导致对睡眠不满意感。

短期失眠是应激性失眠常见病类，是治疗的关键阶段，通过压力管理、药物和非药物干预管理等合理治疗一般都能痊愈。短期失眠若未得到重视及有效管理，大约 40% 可发展成为慢性失眠。慢性失眠由于其病程长，病情较为复杂，临床上多呈现波动性，失眠发作期以药物和非药物管理症状治标为主，缓解期以睡眠行为、心理压力、失眠易感性管理等治本为要，一般经过规范治疗和管理，失眠也都能恢复或痊愈。疫情应激性失眠常用的管理模块如下。

3.1 睡眠教育管理 睡眠教育管理旨在通过普及睡眠健康教育知识，纠正患者对失眠的错误认知和行为，通过加强自我睡眠管理，提高睡商，避免睡眠剥夺。①睡前 4 ～ 6h 内避免接触咖啡、浓茶、可乐、巧克力或吸烟等含咖啡因的饮料和食物，会导致入睡困难、夜间觉醒及浅睡眠。②睡前 3h 不要饮酒，特别是不能利用酒精帮助入睡。③每日规律安排适度的体育锻炼 30min 以上，睡前 3 ～ 4h 内应避免剧烈运动。④规律进餐，且避免空腹上床：睡前可进食少量含碳水化合物的零食，但应避免进食过于油腻或难消化的食物，避免过度饮水。⑤睡前 1h 内不做容易引起兴奋的脑力劳动或观看容易引起兴奋的书刊和影视节目。⑥保持规律的作息时间。⑦卧室应远离光线和噪音，舒适、安静的睡眠环境有利于减少夜间觉醒。必要时可戴眼罩、耳塞；卧室夜间的温度适宜，过冷或过热的睡眠环境可能会影响睡眠；选择合适的床上用品，有助于提高睡眠质量。

3.2 睡眠行为管理 睡眠行为管理旨在通过人为干预睡眠过程，调整生物钟，配合睡前放松疗法，放松心身，诱导睡眠进程。

3.2.1 睡眠时间控制法 睡眠限制疗法：根据患者前 1 周的睡眠状况设置总的睡眠时间（不少于 5h）。规定患者的起床时间，根据起床时间，按 85% 的睡眠效率设置上床时间。如果白天患者小睡和午睡，则夜晚要除去白天的卧床时间；根据患者的睡眠日记，若患者的睡眠效率达到 85%，可以每周增加 15 ～ 20min 的总卧床时间。睡眠限制疗法在早期执行时患者可能会出现一些不良反应，如日间困倦感增强、注意力下降等，但这些症状会随着治疗时间的延长慢慢改善。

刺激控制疗法：这是一种强制性治疗，将日间活动和夜间睡眠环境之间进行区分。只有晚上有睡意或到了规定的睡眠时间再上床休息。若上床后 30min 无法入睡，应离开卧室直至有困意时再上床，若仍无睡意，应再次离开床。逐步建立睡眠与床之间的条件反射。

3.2.2 睡前放松疗法 睡前进行适度的活动有助于转移注意力，放松身心，帮助睡眠，常用的运动疗法包括腹式呼吸法、渐进式肌肉放松技术、中医气功入静疗法等。

腹式呼吸法：这种呼吸方式与睡眠时的呼吸方式类似，能诱导呼吸更慢更深。具体方法如下：①感受自己的呼吸方式：躺在床上或坐在沙发上，左手放在胸部，右手放在腹部肚脐处，平静呼吸，去感受双手在上下起伏，并比较双手的运动幅度。②练习和体会腹式呼吸：缓缓地通过鼻孔呼吸，吸气时让腹部慢慢地鼓起来，呼气时让腹部慢慢地凹下去，体会腹部起伏的感觉，通过比较双手的运动幅度去感受与之前惯常呼吸方式的不同。③练习几分钟之

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

后，坐直，休息一下，保持双手位置不变，接着进行腹式呼吸，比较两手在吸气和呼气时的运动幅度，并判断哪一只手的运动更明显。若双手运动幅度不一致，可能意味着还未掌握腹式呼吸的技巧，需要继续练习。

渐进式肌肉放松：此方法可以减轻骨骼肌的紧张程度。具体方法如下：①以最舒服的姿势坐在舒适的椅子上，闭眼，接着深吸气，缓慢呼气。②呼气时，感受双肩下沉，肩部肌肉放松；继续深吸气、缓慢呼气，感受到肩膀在下沉、放松的同时，肌肉放松逐渐扩展到上肢、指尖、躯干、下肢、脚趾等部位。③继续深吸气、缓慢呼气，感受肩膀、躯干、四肢的肌肉放松，颈部和头部也同时得到放松。④继续进行几个周期的深呼吸，缓慢呼气时感受全身肌肉的放松，最终感觉全身放松、心情平静，帮助入睡。

中医气功入静疗法：晚临睡前，先观想一下百会穴、涌泉穴，从这两个穴位吸入天地自然之精气，使之在脐正中的神阙穴化合，再上行至手心劳宫穴。卧床后，排除杂念，身体放松，默念“六字诀”以诱导入睡，六字诀即呼气声念：“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”六字，此法可调和脏腑，对诱导入睡有益处。

注意各种放松训练的方法均需要不断地练习，才能获得良好的效果。开始时，应该在白天练习，3次/d，待熟练后，再放到睡前使用以协助改善睡眠。

3.2.3 压力管理 压力又称为心理应激，是指来自心理、社会、文化的各种事件被大脑皮层接受，在认知、人格特征等因素的作用下，大脑将刺激信号加以转换成为抽象观念，并进行加工、处理、储存，再通过神经—内分泌—免疫系统间的相互作用，导致各种疾病的发生，是心身疾病的源头。

压力管理旨在通过了解疫情期间如何处理常见的心理应激反应的知识，学习自我调节情绪的方法，缓解心理应激状态，帮助睡眠。下面简述几种常用的调适技术。

3.2.3.1 认知疗法 需使患者自我认识到对睡眠的消极思考会增加唤醒阈值。在傍晚留出15～20min的时间写下问题，为第2天制订计划，并解决夜间可能出现的任何顾虑，进行“我已经解决了这个问题”自我暗示。另一种认知疗法是尽量保持清醒，从而加强睡眠驱动力。也可采用网络认知行为疗法寻求治疗[41]。

3.2.3.2 正念睡眠疗法 关注当下，正性加工思维，将“行动模式”转变为“存在模式”，将“担忧失眠”转变为“接纳失眠”，常用方法：正念呼吸，身体扫描，思维和情绪的觉知训练。

3.2.3.3 中医五音疗法 属于音乐疗法的一种，主要是针对患者的病证及具体情况，遵循中医辨证论治的原则，选择与其相应的五行音乐曲目，开出音乐处方，达到防病、治病之目的。如宫音和平雄伟，庄重宽宏，使人温良而宽大，为土音，通于脾，能促进全身气机的稳定，调节脾胃之气的升降。代表曲目有《秋湖月夜》《鸟投林》《闲居吟》《马兰开花》等。

3.2.4 失眠易感性管理 在调节失眠易感性方面，中医有着丰富的经验和优势，通过调整体质、疏通经络、调理脏腑阴阳等方式，提高人体面对应激的应对能力。

3.2.4.1 中医体质调适法 中医将人分为九种体质，应激性失眠多与气郁质、气虚质关系密切。平时可以根据不同体质类型进行相应调理，如气郁质居室宜保持宽敞明亮，尽量增加户外与社交活动，听积极向上的音乐等调达气机，恢复阴阳平衡、气血调达的状态。

3.2.4.2 中医行为调适法 中医认为，运动行为可以疏通经络、调畅气机。常用的中医行为疗法包括太极拳、八段锦、五禽戏等。根据失眠患者的不同体质可以选择不同的运动方式，气郁质宜选择较大强度的运动锻炼如跑步、打球等，做瑜伽牵拉胆经，以疏肝理气。气虚质运动应循序渐进，以慢跑、健步走、传统健身功法为主，不宜汗出过多等。

3.2.4.3 中医饮食调适法 中医理论认为“药食同源”，具有直接或间接安神助眠作用的中药有酸枣仁、茯苓、淡竹叶、百合、大枣、龙眼肉、莲子、栀子、淡豆豉、决明子、菊花、佛手、阿胶、郁李仁、紫苏叶等，可以制备成药膳，通过辨证（体）与辨病相结合来论治和施养。

龙胆竹叶粥：龙胆草3g，淡竹叶15g，酸枣仁15g，白米50g。先水煎龙胆草、淡竹叶、酸枣仁，过滤取汁，备用。白米加水煮粥，半熟后加入药汁，煮至米烂粥稠，加冰糖适量调味，代早餐服食。适用于肝郁化火之不寐。

小麦百合生地汤：小麦30g，百合15g，生地15g，生龙齿15g，白芍12g，酸枣仁10g，山药15g，小麦布包与余药共煎去渣，饮汤作服，用于心胆气虚之不寐。

玄参百合粥：玄参15g，百合30g，合欢皮15g，粳米100g。先水煎上3味药，取汁，加米煮粥，晨起做早餐食之。适用于阴虚火旺之不寐。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

茯苓龙眼粥：茯苓30g，龙眼肉30g，糯米50g，冰糖适量。将粳米洗净，放入砂锅，加适量水，再放入龙眼肉、茯苓末共煮成粥，加入冰糖调味。代早餐或点心服食。适用于心脾两虚之不寐。

同时可以根据体质特点和食物的性味归经，选用适宜食物，长期坚持能够改善人体脏腑的盛衰偏颇。阳虚质宜选用温补脾阳、肾阳的食物，如羊肉、生姜等，少食生冷、苦寒的食物，如螃蟹、梨等以免损伤阳气。气郁质宜选用疏肝理气解郁的食物，如玫瑰花、金橘等，少食收敛酸涩的食物，如石榴、乌梅等。气虚质宜选用健脾益气的食物，如小米、山药等，尽量少吃或不吃生萝卜等耗气之品[42]。

3.2.5 药物干预管理 中医治疗失眠以辨证论治为基础，以补虚泻实、调和阴阳为治则。在天人合一整体观念指导下，顺应昼夜节律变化，可采用昼夜分治法，白天方药以调和脏腑气血阴阳偏颇，夜间方药以宁心安神、镇静助眠为主，多采用酸枣仁汤随证加减，旨在恢复人体“昼精夜寐”的生理状态。

临床实践证实，失眠的中医辨证论治疗效显著，且没有长期应用镇静安眠药的依赖、宿醉、肌松、记忆力受损等不良反应，建议以失眠为主症的患者可早期全程使用。针对轻度失眠或失眠缓解期也可合理选用中成药如乌灵胶囊[43]、舒眠胶囊[44]、甜梦口服液[45]、安神补脑液[46]、天王补心丹[47]、百乐眠胶囊[48]、枣仁安神胶囊[49]、柏子养心丸[50]、心神宁片[51]等，方便服用，或巩固疗效；针对重度失眠、顽固性失眠可采取中西医结合治疗，在中医理论“急则治其标”的指导下，为了尽快控制失眠症状，睡前可配合镇静安眠类西药，如右佐匹克隆、唑吡坦和艾司唑仑等，患者可以按需短期使用，症状缓解后即可停药；针对负性生活事件等慢性压力持续存在，焦虑抑郁情绪反应明显的患者，可联合适量抗焦虑抑郁类药物如氟哌噻吨美利曲辛、坦度螺酮、氟西汀、舍曲林、西酞普兰、帕罗西汀、度洛西汀、文拉法辛、米氮平等。

疫情应激性失眠常见辨证论治方案如下。

3.2.5.1 肝郁化火型 临床表现：突发失眠，性情急躁易怒，心烦不能入睡，性情急躁易怒，或入睡后多梦惊醒。胸胁胀闷，善太息，口苦咽干，目赤，小便黄，大便秘结。舌质红苔黄，脉弦数。

治则治法：疏肝泻火安神。

推荐方药：丹栀逍遥散加减。

3.2.5.2 痰火内扰型 临床表现：失眠时作，噩梦纷纭，易惊易醒。头目昏沉，脘腹痞闷，口苦心烦，饮食少思，口黏痰多。舌质红苔黄腻或滑腻，脉滑数。

治则治法：清化痰热，和中安神。

推荐方药：黄连温胆汤加减。

3.2.5.3 阴虚火旺型 临床表现：虚烦不眠，入睡困难，夜寐不安，甚则彻夜难眠。手足心热，盗汗，口干少津，健忘耳鸣，腰酸梦遗，心悸不安。舌质红少苔，脉细数。

治则治法：滋阴清热，宁心安神。

推荐方药：六味地黄丸合交泰丸加减。

3.2.5.4 心脾两虚型 临床表现：头蒙欲睡，睡而不实，多眠易醒，醒后难以复寐。心悸、健忘，神疲乏力，纳谷不香，面色萎黄，口淡无味，食后作胀。舌质淡苔白，脉细弱。

治则治法：补益心脾，养心安神。

推荐方药：归脾汤加减。

3.2.5.5 心胆气虚型 临床表现：心悸胆怯，不易入睡，寐后易惊。遇事善惊，气短倦怠。舌质淡苔白，脉弦细。

治则治法：益气镇惊安神。

推荐方药：安神定志丸加减。

3.2.6 非药物干预管理 失眠的非药物治疗技术非常丰富，具有简、便、验、廉、无明显不良反应、依从性好的优势，属于失眠的绿色治疗技术。建议进一步挖掘整理提升，形成适宜技术，作为失眠的一线治疗，推广应用。

3.2.6.1 针灸推拿疗法 针灸常用效穴：百会、四神聪、神庭、内关、大陵、心俞、神道、申脉、照海、印堂、神门、安眠、三阴交、安眠、风池、太溪、行间[52]。推拿按摩：患者取坐位或卧位，医者以一指禅推法或揉法操作于印堂、神庭、太阳、头维、百会，约10min；医者以一指禅推法或揉法操作于眼眶及睛明、鱼腰、攒竹诸穴，约5min；医者以拿法从头顶操作至枕部风池穴，反复3～4遍，约5min。隔日治疗1次，10次为1个疗程[53]。

艾灸对失眠疗效确切[54]，取心俞、肾俞、太冲、百会、涌泉、神门、内关、阳陵泉等穴位，灸法以回旋灸为主，雀啄灸加强，辅以平补平泻，刺激强度以患者耐受为度，每次治疗30min，每日2次，1个月为1个疗程。

3.2.6.2 穴位贴敷疗法 贴敷药物由远志、当归、黄芪、菖蒲等药物组成，充分干燥后将药物粉碎，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与辅助成分按照1:1的比例混合而成，制作成贴剂，在患者睡前30min前敷贴在气海穴、神阙穴、足三里穴，敷贴6～12h/次，隔天1次，6周为1个疗程[55]。

3.2.6.3 足浴方 首乌藤30g、远志30g、合欢皮30g、盐柏20g、黄连10g、肉桂5g，将上述诸味药材先放入冷水中浸泡15～30min，然后水煎去渣并加入3000ml热水，确保药液刚好没过患者脚踝，泡脚时间为睡前，每日1次，每次泡脚时间控制在0.5h左右，患者自觉后背发潮或者额头微微出汗即可，药液的温度在38～45℃。10天为1个疗程[56]。

3.2.6.4 睡眠药枕 夏枯草100g、决明子100g、野菊花100g、夜交藤100g、合欢米100g、玫瑰花100g，以上各药翻晒、烘干并研为粗末，混匀后用纱布包裹缝好，装入枕芯即可。可制成圆形、常方形等自我感觉舒适的款式，枕高宜控制在7～12cm，以患者自我舒服为佳。

3.2.6.5 刮痧调理 采用全头部刮痧联合辨证取穴[57]。全头部刮痧采用四神延刮法、颞部刮法、维风双带刮法和项丛刮法。辨证取穴：痰热扰心加刮神门穴、丰隆穴和足三里穴；阴虚火旺者加刮神门穴、太溪穴和三阴交穴；肝火扰心者加刮神门穴、肝俞穴和太冲穴。前2周每周刮拭2次，以后每周刮拭1次，5次为1个疗程。

3.2.7 失眠共病管理 失眠容易引发或共病精神心理疾病、躯体疾病，共病存在形成恶性循环，对个体的危害更为显著。

3.2.7.1 共病精神心理疾病 面对疫情，人们开始出现各式各样的心理和精神问题，包括焦虑、抑郁、愤怒、记忆力减退等，也可能出现强迫，甚至压力相关的躯体症状，如头晕、头痛、恶心等，失眠患者可能更易出现上述症状，直接影响了个体的生活质量，严重者还会出现自杀风险。所以需要及时评估患者的精神心理症状、躯体化症状和自杀风险，故宜早期进行失眠管理，进而中断恶性循环。

3.2.7.2 共病躯体疾病 失眠与肥胖、糖尿病、高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、胃肠道疾病、免疫系统疾病、癌症等躯体疾病可互为因果、恶性循环，直接威胁公众的生命健康和生活质量。如疫情应激性失眠可以使血压血糖波动、体内炎症因子增加，诱发心脑血管病，甚至猝死；入睡困难、睡眠维持困难、1周超过1次的睡眠质量下降均增加突发心力衰竭的风险[58]。所以需要对失眠和共病躯体疾病进行共同治疗。

3.2.8 特殊人群管理

3.2.8.1 儿童和青少年 研究显示，儿童及青少年的失眠患病率约为20%[59]，超六成青少年儿童睡眠时间不足8h，且仅有18.0%的青少年儿童醒后精力充沛[60]，20%～30%的幼儿存在就寝问题和夜醒，15%的学龄儿童表现出就寝抗拒，9%～24%的青少年经历过慢性失眠[40]。儿童及青少年失眠受青春期生理发育、学校及家庭等社会环境、心理行为等多种因素影响，囊括了入睡困难、睡眠时间不足、睡眠质量差和日间困倦等一系列症状，明显影响其精神状态和生活学习质量。儿童及青少年失眠的治疗方法以睡眠卫生教育、认知行为治疗、非药物治疗等综合管理为主。

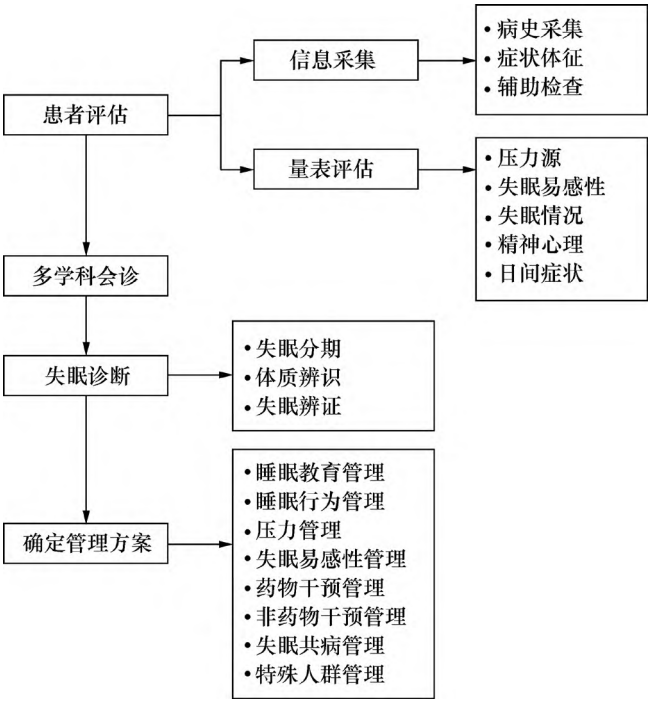
3.2.8.2 妊娠及哺乳期妇女 孕期女性对于自身睡眠的关注程度常常较高，孕期极易出现情绪及睡眠障碍，孕妇失眠发生率远高于正常人群，随着孕周的增加，睡眠问题越突出，流行病学显示[61]，孕早期失眠发生率约为34%，孕中晚期则高达68%～80%，可表现为失眠、睡眠模式改变、睡眠效率下降、打鼾、不宁腿综合征等多种睡眠障碍。应激性失眠在妊娠期及哺乳期也很常见，其可导致不良妊娠结局，如围产期抑郁、妊娠糖尿病、先兆子痫、早产、产后焦虑和抑郁等，宜以早预防、早诊断、早干预，以睡眠卫生教育、认知行为治疗、非药物治疗等绿色治疗为主，必要时配合中医辨证论治调适。

3.2.8.3 更年期妇女 应激性失眠是围绝经期和绝经期患者妇女的普遍问题，更年期睡眠障碍包括睡眠启动和维持困难、频繁夜间觉醒和睡眠质量不佳。相比绝经前，绝经后女性的睡眠质量更差，会出现睡眠潜伏期和夜间清醒时间延长[62]。更年期失眠与生理、心理、社会应激密切相关。宜尽早采用中医辨证论治干预、非药物干预、心理压力管理等综合治疗。

3.2.8.4 中老年人 老年人为疫情应激性失眠的高发人群，研究显示[63]，疫情下，82.7%的中老年人对睡眠不满意，59.1%存在不同程度的入睡困难，同时失眠也会对老年人造成明显的近期和远期心理健康损害。老年患者一般病程较长，深睡眠时间短，病情复杂且易反复，常共病焦虑、抑郁等负性情绪及高血压、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑血管病、肿瘤等慢性病。对于老年患者，宜尽早进行药物干预管理，尽快缓解失眠症状为要。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附：疫情应激性失眠管理流程图



专家组成员（以姓氏笔画为序）：王显（北京中医药大学东直门医院），李顺民（广州中医药大学深圳市中医院），杨东东（成都中医药大学附属医院），杨秋莉（中国中医科学院），张捷（首都医科大学附属北京中医医院），纳贡毕力格（内蒙古国际蒙医医院），庞铁良（首都中医药大学附属北京安定医院），赵鹏（北京中医药大学东直门医院），徐建（上海中医药大学附属上海市中医院），郭蓉娟（北京中医药大学东方医院），黄立中（湖南中医药大学），黄俊山（福建省中医药科学院），詹淑琴（首都医科大学宣武医院），虞鹤鸣（南京中医药大学附属南京市中医院）

主要执笔人：郭蓉娟、徐建、李顺民、赵鹏

参考文献：

[1] SPIELMAN A J, CARUSO L S, GLOVINSKY P B, et al. A behavioral perspective on insomnia treatment[J]. Psychiatr Clin North Am, 1987, 10(4): 541-553.

[2] HAN K S, KIM L, SHIM I, et al. Stress and sleep disorder[J]. Exp Neurobiol, 2012, 21(4): 141-150.

[3] KANG L, LI Y, HU S, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus[J]. Lancet Psychiatry, 2020, 7(3): e14.

[4] HAN K S, KIM L, SHIM I, et al. Stress and sleep disorder[J]. Exp Neurobiol, 2012, 21(4): 141-150.

[5] RIEMANN D, SPIEGELHALDER K, FEIGE B, et al. The hyperarousal model of insomnia: A review of the concept and its evidence[J]. Sleep Med Rev, 2010, 14(1): 19-31.

[6] ELLIS J G, GEHRMAN P, ESPIE C A, et al. Acute insomnia: current conceptualizations and future directions[J]. Sleep Med Rev, 2012, 16(1): 5-14.

[7] SHER L. COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide[J]. Sleep Med, 2020(70): 124.

[8] WU K, WEI X. Analysis of psychological and sleep status and exercise rehabilitation of front-line clinical staff in the fight against COVID-19 in China[J]. Med Sci Monit Basic Res, 2020(26): e924085.

[9] XIAO H, ZHANG Y, KONG D, et al. The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China[J]. Med Sci Monit, 2020(26): e923549.

[10] 韩芳, 唐向东, 张斌. 中国失眠症诊断和治疗指南[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(24): 1844-1856.

[11] 失眠定义、诊断及药物治疗共识专家组. 中国失眠定义、诊断及药物治疗专家共识(草案)[S]. 中华神经科杂志, 2006(2): 141-143.

[12] 张娅, 黄俊山, 吴松鹰, 等. 基于中医阴阳寤寐学说的原发性失眠阴证/阳证临床辨识系统初探[J]. 中医杂志, 2016, 57(20): 1754-1758.

[13] 李军祥, 陈誌, 冯五金, 等. 消化心身疾病中西医结合整体诊治专家指导意见(2017年)[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018, 26(1): 9-17.

[14] 唐峥华, 韦波, 苏莉, 等. 突发公共卫生事件下心理反应问卷的编制[J]. 现代预防医学, 2007(21): 4050-4053.

[15] 杨德森. 行为医学[M]. 长沙: 湖南师大出版社, 1990: 285-287.

[16] HOLMES T H, RAHE R H. The social readjustment rating scale[J]. J Psychosom Res, 1967, 11(2): 213-218.

[17] BROWN G W, HARRIS T. Social origins of depression: A study of psychiatric disorders in women[M]. London: Tavistock, 1978.

[18] 高存友, 甘景梨, 赵兰民, 等. 福特应激失眠反应测试量表中文版的初步应用[J]. 临床精神医学杂志, 2014, 24(5): 305-307.

[19] SPIEGEL R. Sleep and sleepiness in advanced age[M]. Jamaica, NY: Spectrum Publications, 1981: 272.

[20] DAMIANI M F, QUARANTA V N, FALCONE V A, et al. The Epworth sleepiness scale: conventional self vs physician administration[J]. Chest, 2013, 143(6): 1569-1575.

[21] HORNE J A, QSTBERG O. A self-assessment queationaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms[J]. Int J Chronobiol, 1976, 4(2): 97-110.

[22] 刘贤臣, 唐茂芹, 胡蕾, 等. 匹兹堡睡眠质量指数的信度和效度研究[J]. 中华精神科杂志, 1996, 29(2): 103-107.

[23] MORIN C M, BELLEVILLE G, BELANGER L, et al. The insomnia severity index: psychometric indicators to detect insomnia cases and evaluate treatment response[J]. Sleep, 2011, 34(5): 601-608.

[24] 肖卫东, 刘平, 马弘, 等. 睡眠障碍评定量表的信度和效度分析[J]. 中国心理卫生杂志, 2007, 21(1): 40-41, 51.

[25] MORIN C M, VALLIÈRES A, IVERS H. Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep (DBAS): validation of a brief version (DBAS-16)[J]. Sleep, 2007, 30(11): 1547-1554.

[26] PINTO JR L R, ALVES R C, CAIXETA E, et al. New guidelines for diagnosis and treatment of insomnia[J]. Arq Neuropsiquiatr,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2010, 68(4): 666-675.
[27] LITTNER M, HIRSHKOWITZ M, KRAMER M, et al. Practice parameters for using polysomnography to evaluate insomnia: an update[J]. Sleep, 2003, 26(6): 754-760.
[28] ZUNG W W. A rating instrument for anxiety disorders[J]. Psychosomatics, 1971, 12(6): 371-379.
[29] HAMILTON M. The assessment of anxiety states by rating[J]. Br J Med Psychol, 1959, 32(1): 50-55.
[30] ZUNG W W. A SELF-RATING DEPRESSION SCALE[J]. Arch Gen Psychiatry, 1965(12): 63-70.
[31] HAMILTON M. A rating scale for depression[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1960, 23(1): 56-62.
[32] KROENKE K, SPITZER R L, WILLIAMS J B. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure[J]. J Gen Intern Med, 2001, 16(9): 606-613.
[33] BECK A T, WARD C H, MENDELSON M, et al. An inventory for measuring depression[J]. Arch Gen Psychiatry, 1961(4): 561-571.
[34] BEN-PORATH Y S, TELLEGEN A. MMPI–2–RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory–2–Restructured Form): Manual for administration, scoring, and interpretation. [M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
[35] 龚耀先. 艾森克个性问卷在我国的修订[J]. 心理科学通讯, 1984(4): 13-20.
[36] DEROGATIS L R, LIPMAN R S, COVI L. SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale--preliminary report[J]. Psychopharmacol Bull, 1973, 9(1): 13-28.
[37] KROENKE K, SPITZER R L, WILLIAMS J B. The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms[J]. Psychosom Med, 2002, 64(2): 258-266.
[38] 王天芳, 薛晓琳. 疲劳自评量表[J]. 中华中医药杂志, 2009, 24(3): 348-349.
[39] 中国中医科学院失眠症中医临床实践指南课题组. 失眠症中医临床实践指南(WHO/WPO)[J]. 世界睡眠医学杂志, 2016, 3(1): 8-25.
[40] 陆林, 中国失眠障碍综合防治指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
[41] SEYFFERT M, LAGISETTY P, LANDGRAF J, et al. Internet-Delivered cognitive behavioral therapy to treat insomnia: A systematic review and meta-analysis [J]. PLoS One, 2016, 11(2): e0149139.
[42] 王宁, 李希, 马淑丽, 等. 基于体质学说失眠中医健康管理思路探讨[J]. 光明中医, 2019, 34(10): 1490-1492.
[43] 马爱琴, 蒋毅玲, 周晓媚. 乌灵胶囊治疗焦虑性失眠症临床研究[J]. 新中医, 2020, 52(6): 44-46.
[44] 贺恩彪, 吕斌军, 武勇法. 舒眠胶囊治疗失眠症疗效观察及对PSQI的影响[J]. 新中医, 2020, 52(1): 74-76.
[45] 李钊, 郝国建, 李广玉, 等. 甜梦口服液结合心理疗法治疗失眠症疗效观察[J]. 世界睡眠医学杂志, 2018, 5(4): 433-435.
[46] 车晓程. 安神补脑液联合太极拳训练治疗失眠临床研究[J]. 亚太传统医药, 2016, 12(10): 129-130.
[47] 覃煜, 陈佩杰, 孔佑一, 等. 天王补心丹治疗阴虚慢性失眠疗效分析[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(28): 158.
[48] 石效荣, 刘义升, 李艳江, 等. 百乐眠胶囊用于失眠症治疗的临床疗效观察[J]. 世界睡眠医学杂志, 2019, 6(9): 1201-1202.
[49] 吴时可, 姜雪松. 枣仁安神胶囊治疗失眠症有效性、安全性的随机双盲安慰剂平行对照研究[J]. 世界睡眠医学杂志, 2020, 7(1): 5-8.
[50] 刘红霞, 雷艳军, 龚靖渊, 等. 加减柏子养心丸治疗失眠42例的临床观察[J]. 医疗装备, 2016, 29(2): 156-157.
[51] 景兴文, 刘福友, 陈维. 心神宁片治疗失眠症心脾两虚兼虚热内扰证临床观察[J]. 新中医, 2013, 45(5): 27-29.
[52] 张霜梅, 吉晶, 邱朝阳, 等. 单纯针灸对比西药治疗卒中后失眠随机对照试验的Meta分析[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(12): 2843-2852.
[53] 张坤木, 李长辉, 宋红梅, 等. 经穴推拿技术治疗失眠的临床效果[J]. 按摩与康复医学, 2020, 11(7): 6-8.
[54] 吴少霞, 刘真真, 李思逸. 雷火灸治疗肝郁阴虚型失眠的临床效果[J]. 中国医药导报, 2019, 16(9): 149-153.
[55] 何蕴秋. 中药联合穴位敷贴对失眠患者睡眠状况的改善作用[J]. 世界睡眠医学杂志, 2019, 6(12): 1671-1673.
[56] 张平. 中药足浴方剂泡脚治疗失眠症患者疗效价值[J]. 中国农村卫生, 2018(22): 42.
[57] 俞建珍, 张钰璇, 朱美华. 刮痧治疗失眠的临床疗效[J]. 江苏医药, 2019, 45(5): 500-502.
[58] LAUGSAND L E, STRAND L B, PLATOU C, et al. Insomnia and the risk of incident heart failure: a population study[J]. Eur Heart J, 2014, 35(21): 1382-1393.
[59] GRAU K, PLENER P L. Pharmacotherapy for children and adolescents with sleep disorders: an overview[J]. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother, 2018, 46(5): 393-402.
[60] 中国睡眠研究会. 2019中国青少年儿童睡眠指数白皮书[C/O]. 北京: 中国睡眠研究会, 2019.
[61] WILKERSON A K, UHDE T W. Perinatal sleep problems: causes, complications, and management[J]. Obstet Gynecol Clin North Am, 2018, 45(3): 483-494.
[62] 陆欢, 吴旭, 胡蔚萍, 向桂玲, 等. 绝经期睡眠障碍治疗临床实践指南解读[J]. 世界临床药物, 2020, 41(4): 247-252.
[63] 王梦雨, 刘小蕾, 郭虹, 等. 新型冠状病毒肺炎疫情下中老年人的心理健康状况[J]. 中华老年多器官疾病杂志, 2020, 19(4): 241-245.

收稿日期：2022-07-30；修回日期：2022-08-04
（本文编辑：高天虹）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net